

互联网使用情况对我国老年人健康状况的影响

韦 灿

中国人民公安大学公安管理学院, 北京, 100038

摘 要 目的:探讨互联网使用情况对我国老年人健康状况的影响,为改善我国老年人健康状况提供参考。**方法:**使用2011—2020年中国健康与养老追踪调查5期数据构建面板数据,选取31339名60岁及以上的老年人作为研究对象,通过双向固定效应模型分析老年人互联网使用情况对其健康状况的影响。**结果:**基于面板数据的双向固定效应模型结果表明,互联网使用情况对老年人身体健康状况($\beta = -0.084, P < 0.01$)、心理健康状况($\beta = -1.147, P < 0.01$)和自评健康状况($\beta = 0.178, P < 0.01$)均有显著影响,该影响通过文体娱乐与志愿服务的社会参与机制实现;相较于西部地区的老年人、中高龄老年人,互联网使用情况对中部地区的老年人和低龄老年人健康状况的影响更显著($P < 0.05$)。**结论:**互联网使用情况显著影响我国老年人健康状况,应借助“互联网+医疗健康”平台便利老年医疗,开展社区科普提升其健康素养。考虑到地区和年龄异质性,西部应加大数字基建投入力度,降低老年人网络使用成本;针对不同年龄段老年人分层开展数字教育,推动老年人在数字时代实现健康老龄化,共享信息化发展成果。

关键词 老年健康;互联网使用;老年人

中图分类号: R-05; R193.2

文献标识码: A

DOI: 10.13723/j.yxysh.2026.05.008

文章编号: 1006-5563(2026)05-0055-08

Impact of Internet Use Situation on Health Status of Chinese Older Adults

WEI Can

School of Public Security Management, People's Public Security University of China, Beijing, 100038, China

Abstract Objective: To explore the impact of Internet use situation on the health status of older adults in China and provide references for improving the health status of older adults in China. **Methods:** Panel data were constructed using the five waves of data of 2011–2020 China health and retirement longitudinal study. A total of 31339 older adults aged 60 years and above were selected as the research subjects, and a two-way fixed effects model was used to analyze the impact of Internet use situation on the health status of these older adults. **Results:** Results from the two-way fixed effects model based on panel data show that Internet use situation has a significant impact on the physical health status ($\beta = -0.084, P < 0.01$), mental health status ($\beta = -1.147, P < 0.01$), and self-rated health status ($\beta = 0.178, P < 0.01$) of older adults. This impact is achieved through the social participation mechanism of cultural and recreational activities as well as voluntary services. Compared with older adults in western China and those of middle-advanced age, the impact of Internet use situation on the health status of older adults in central and eastern China and those of young-old age is more significant ($P < 0.05$). **Conclusion:** Internet use situation significantly affects the health status of Chinese older adults. It is necessary to leverage "Internet + healthcare" platforms to facilitate healthcare for older adults and carry out community science popularization to enhance their health literacy. Considering regional and age heterogeneity, western regions should increase investment in digital infrastructure to reduce Internet usage costs for older adults. Stratified digital education should be provided for older adults of different age groups, promoting healthy aging in the digital era and enabling older adults to share the fruits of information development.

Key Words Elderly Health; Internet Use; Older Adult

我国老龄化程度逐步加深,老年人普遍面临慢性病高发、身体机能衰退引发的社交受限问题,这种生理与心理的恶性循环往往导致社会孤立与情感疏

离,形成复合型健康危机^[1-2]。值得注意的是,数字化浪潮为化解老年健康困境提供了新路径。老年人使用互联网可以满足其交往需求,增加归属感,改善

基金项目:国家社会科学基金资助项目,编号为25BZZ008

其健康状况^[3]。一方面,既有研究对互联网使用情况与老年人健康状况的关系进行探讨。翟亚等基于 2018 年中国家庭追踪调查数据发现,互联网使用能降低老年人抑郁症状发生的风险^[4]。Rennoch 等研究表明,老年人通过互联网获取信息、社交、学习等,可提升生活体验,缓解抑郁症状,证实互联网使用对老年人心理健康的积极作用^[5]。在身体健康方面,Li 等通过前瞻性队列研究发现,日常使用互联网的老年人慢性疾病患病风险更低,证实互联网使用对老年健康的促进作用^[6]。吴怡萱等则指出,互联网使用能减少老年人孤独感,进而对躯体健康产生积极影响,揭示其在维护老年人身体健康方面的潜在价值^[7]。此外,有学者将视野扩展至健康生活方式与群体差异,汤华萌等探讨了互联网使用情况对我国城乡老年人健康生活方式的影响,分析了互联网使用情况与健康生活方式相关行为的关联^[8]。王胜今等从性别差异和代际支持的视角,研究了互联网使用情况对老年人健康状况的影响,考察了不同性别老年人及代际支持水平下互联网使用情况与健康状况的关系^[9]。另一方面,关于作用机理的研究也不断丰富。王文超等以空巢老人为对象,证实日常生活活动能力和社会参与在互联网使用缓解抑郁症状中存在链式中介作用,揭示了互联网通过影响社会参与改善老年人心理健康的路径^[10]。郭静等则强调不同年龄老年人在互联网使用效应上存在差异,低龄老年人更善于借助互联网拓展社交网络、降低孤独感,从而实现更好的健康收益^[11]。综上所述,既有研究虽揭示了互联网使用对老年健康的积极作用,但多集中于心理或身体健康单一维度,缺乏从整体健康出发的系统性分析;在作用机理上,也多局限于孤立变量,缺乏多维度整合。基于此,本研究基于中国健康与养老追踪调查 2011—2020 年 5 期追踪数据构建平衡面板,运用双向固定效应模型,系统考察互联网使用情况对老年人身体健康、心理健康与自评健康的整体效应,并将文体娱乐和志愿服务等社会参与机制纳入作用路径。同时,结合地区差异与年龄分层,深入探讨不同地区和不同年龄老年人的异质性影响,为改善老年人健康状况提供更具针对性的理论依据与实践借鉴。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

数据来源于中国健康与养老追踪调查(China health and retirement longitudinal study, CHARLS)^[12],

该调查由北京大学中国社会科学调查中心实施,是一项旨在收集中国 45 岁及以上中老年人家庭和个人高质量微观数据的大型跨学科项目。其中,最新一期为 2020 年的全国追访,其数据于 2023 年 11 月 16 日正式公开发布。该数据库包含了受访者互联网使用情况、身体和心理健康状况、人口统计学特征等信息,满足本研究所需的样本信息。本研究采用 2011—2020 年 5 期追踪数据构建面板数据,选取年龄大于或等于 60 岁的老年人作为样本,剔除老年人互联网使用情况、健康状况等核心变量缺失的样本,最终获得 31339 个有效样本。

1.2 变量选取

1.2.1 被解释变量。将健康状况作为被解释变量,具体包括身体健康、心理健康和自评健康 3 个维度。身体健康状况通过 CHARLS 中身体功能障碍和辅助功能数据测量,考察日常生活能力(activities of daily living, ADL)与工具性日常生活能力(instrumental activities of daily living, IADL)^[13]。ADL 包含穿衣、洗澡、吃饭、上下床、如厕和控制大小便 6 个指标,IADL 包括做家务、做饭、购物、吃药和管理财务 5 个指标。各项问题的回答分为“没有困难”“有困难但仍可以完成”“有困难,需要帮助”和“无法完成”。若任意指标选取后两项,则视为存在困难并赋值为 1,否则赋值为 0。以 ADL 的 6 个指标为核心,统计其中“存在困难”的指标数量,进而对身体健康状况进行综合赋值,取值范围为 0—6^[14-15]。心理健康状况采用流行病学研究中心抑郁量表 10 项版(center for epidemiologic studies depression scale 10, CES-D10)进行测量,该量表评估老年人过去一周内的抑郁情绪、愉悦感缺失、躯体不适等抑郁相关症状,按照<1 天赋值为 0、1—2 天赋值为 1、3—4 天赋值为 2、5—7 天赋值为 3,其中“我对未来充满希望”和“我很愉快”2 个条目反向赋值。各条目得分累加,总分范围为 0—30,分值越高表明抑郁症状越严重,分值越低则表明心理健康状况相对较好^[16-17]。由此可对个体的心理健康状况进行间接评价。最后,为更全面反映个体的健康水平,本研究还引入自评健康指标作为补充测量。自评健康通过问题“认为自身身体和心理健康状况如何”加以获取,采用 Likert 5 级量表评分,分值越高表示自我感知的健康状况越好^[18]。考虑到自评健康能够综合体现个体对身体与心理状态的主观感受,同时也反映了难以通过客观指标完全捕捉的健康维度,因此纳入分析具有重要意义。

1.2.2 解释变量。将互联网使用情况作为核心解释

变量。参考既往相关文献^[19],选取 CHARLS 调查中关于“过去 1 个月是否上网”的问题作为衡量依据。若受访老年人报告在过去 1 个月中曾使用互联网,则其互联网使用情况变量赋值为 1;反之,若未使用互联网,则赋值为 0。

将社会参与情况作为中介变量。为深入剖析老年人互联网使用情况经由社会参与路径对其健康状况产生影响的内在机制,参考相关研究^[20-21],将社会参与细化为文体娱乐参与情况、志愿服务参与情况两个方面。文体娱乐参与情况可以通过日常娱乐活动和身体锻炼活动的参与情况来表现出来,参与赋值 1,未参与赋值 0;志愿服务参与情况以是否投身志愿活动为依据,同样参与赋值 1,未参与赋值 0。

1.2.3 控制变量。参考相关文献^[22-24],老年人健康状况可能受到人口学特征、社会经济条件及生活方式等多方面因素的影响。因此,本研究选择控制变量包括:性别和年龄,用于反映性别和年龄差异对健康的影响;婚姻状况和子女数量,用于反映家庭支持和社会关系对健康的作用;受教育程度和基本医疗保险参保情况,用于衡量社会经济地位与医疗保障对健康的影响;抽烟、饮酒等不良生活习惯,用于控制可能的行为风险因素。通过引入这些变量,可以更准确地评估互联网使用情况对老年人健康状况的独立影响。

1.3 统计学方法

利用 Stata 18.0 软件对数据进行分析,通过基于面板数据的双向固定效应模型分析互联网使用情况对我国老年人健康状况的影响。模型如下:

$$srh_{it} = \alpha_1 + \beta_1 Internet_{it} + \alpha_j Control_{it} + City_i + Year_t + \varepsilon_{it}$$

其中, srh_{it} 是被解释变量,表示我国老年人健康状况, $Internet_{it}$ 是解释变量,表示互联网使用情况, $Control_{it}$ 是控制变量, $City_i$ 和 $Year_t$ 分别代表了城市和时间固定效应,用于控制不随时间变化的城市异质性以及不随个体变化的时间趋势, ε_{it} 是误差项, α_1 为常数项^[25]。

在稳健性检验中,参照既有研究^[26],将因变量替换为工具性日常生活能力和老年人认知功能来对结果进行检验。认知功能包括定向力(5 分)、计算力(5 分)、画图能力(1 分)、即时记忆(5 分)和延时记忆(5 分)5 个部分,总分范围为 0-21 分,得分越高说明认知功能越好。

此外,为进一步挖掘互联网使用情况影响老年人健康状况的内在机制,本研究运用逐步回归法,系统探究社会参与机制在互联网使用情况与老年人健康状况关系中的中介作用。同时,基于地区和年龄

两个维度,分别开展针对性分析,深入探讨不同地区、不同年龄的老年人中,互联网使用情况对其健康状况的影响差异。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究变量基本情况

本研究共纳入 31339 名老年人,其中男性 14958 人(47.73%),女性 16381 人(52.27%);年龄均值为 68.27 岁,标准差为 6.61;在婚老年人有 24953 人(79.62%),非在婚 6386 人(20.38%);受教育程度小学以下 17103 人(54.57%),小学 7331 人(23.39%),初中 4393 人(14.02%),高中及以上 2512 人(8.02%);有基本医疗保险的 60 岁以上老年人有 29615 人(94.50%),没有的有 1724 人(5.50%);抽烟的老年人 8242 人(26.30%),不抽烟的 23097 人(73.70%);喝酒的老年人 9676 人(30.88%),不喝酒的 21663 人(69.12%)。研究对象基本特征见表 1。

表 1 研究变量基本特征

变量	n(%) / [P ₅₀ (P ₂₅ , P ₇₅)]
互联网使用情况	
是	1042(3.32)
否	30297(96.68)
自评健康状况	
很差	1935(6.17)
较差	7348(23.45)
一般	15594(49.76)
较好	3918(12.50)
很好	2544(8.12)
心理健康评分	7(3,13)
身体健康状况	
0 项困难	23654(75.48)
1 项困难	3771(12.03)
2 项困难	1711(5.46)
3 项困难	922(2.94)
4 项困难	604(1.93)
5 项困难	442(1.41)
6 项困难	235(0.75)
性别	
男	14958(47.73)
女	16381(52.27)
婚姻状况	
在婚	24953(79.62)
非在婚	6386(20.38)
受教育程度	
小学以下	17103(54.57)
小学	7331(23.39)
初中	4393(14.02)
高中及以上	2512(8.02)

表 1(续)

变量	n(%)/[P ₅₀ (P ₂₅ , P ₇₅)]
是否有基本医疗保险	
是	29615(94.50)
否	1724(5.50)
是否抽烟	
是	8242(26.30)
否	23097(73.70)
是否喝酒	
是	9676(30.88)
否	21663(69.12)
子女数量	3(2, 4)

2.2 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的基准回归结果

表 2 呈现了互联网使用情况对我国老年人健康状况的基准回归结果,模型 1、模型 2 和模型 3 是未加入控制变量时的基准回归结果,模型 4、模型 5 和模型 6 是加入控制变量后互联网使用情况对老年人健康状况的回归结果。模型 4 结果显示,加入控制变量后互联网使用情况对老年人身体健康状况的回归系数为-0.084, $P<0.01$, 由于身体健康状况是由身体功能障碍和辅助功能数据来表示,存在困难个数越少表明身体越健康,因此互联网使用情况对老年人身体健康状况产生显著影响。模型 5 结果显示,加入控制变量后互联网使用情况对老年人心理健康状况的回归系数为-1.147, $P<0.01$, 由于量表分数越低心理越健康,因此互联网使用情况对老年人心理健康状况产生显著影响。模型 6 结果显示,加入控制变量后互联网使用情况对老年人自评健康状况的

回归系数为 0.178, $P<0.01$, 表明互联网使用情况对老年人自评健康状况产生显著影响。

2.3 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的稳健性检验

表 3 呈现了稳健性检验结果。模型 1、2 将因变量替换为工具性日常生活能力和老年人认知能力以衡量老年人健康状况,模型 3、4、5 通过缩小样本容量、剔除 90 岁以上样本进行回归。稳健性结果显示,替换因变量后,互联网使用情况对老年人健康状况的影响均在 1% 的显著水平上显著 ($P<0.01$), 缩小样本容量后该影响仍在 1% 的显著水平上显著 ($P<0.01$), 表明回归结果的稳健性较好。

2.4 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的作用机制

2.4.1 文体娱乐参与情况在互联网使用情况影响我国老年人健康状况过程中的中介作用。表 4 显示了日常娱乐活动参与情况在互联网使用情况影响老年人健康状况的中介作用。结果表明,互联网使用通过影响老年人日常娱乐活动的参与,显著改善其健康状况 ($P<0.01$), 在身体健康状况以及心理健康状况等方面均表现出积极作用 ($P<0.01$)。

表 5 显示了身体锻炼活动参与情况在互联网使用情况影响健康状况的中介作用。结果表明,互联网使用通过影响老年人身体锻炼活动的参与,显著改善其健康状况 ($P<0.01$), 在身体健康状况以及心理健康状况等方面均表现出积极作用 ($P<0.01$)。

2.4.2 志愿服务参与情况在互联网使用情况影响我国老年人健康状况过程中的中介作用。回归的结果见表 6。

表 2 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的基准回归结果

项目	模型 1 身体健康	模型 2 心理健康	模型 3 自评健康	模型 4 身体健康	模型 5 心理健康	模型 6 自评健康
互联网使用情况	-0.287 *** (0.025)	-2.197 *** (0.199)	0.276 *** (0.041)	-0.084 *** (0.024)	-1.147 *** (0.199)	0.178 *** (0.042)
性别				-0.048 ** (0.020)	-1.551 *** (0.106)	0.027 (0.017)
年龄				0.022 *** (0.002)	-0.023 *** (0.008)	-0.004 *** (0.001)
婚姻状况				-0.074 *** (0.025)	-0.997 *** (0.132)	0.008 (0.018)
受教育程度				-0.082 *** (0.010)	-0.664 *** (0.055)	0.037 *** (0.008)
基本医疗保险情况				-0.061 * (0.035)	-0.303 * (0.172)	-0.031 (0.027)
吸烟情况				-0.074 *** (0.019)	0.227 * (0.121)	0.052 *** (0.019)
饮酒情况				-0.082 *** (0.017)	-0.509 *** (0.100)	0.195 *** (0.014)
子女数量				0.017 ** (0.007)	0.010 (0.041)	-0.007 (0.006)
常数项	0.520 *** (0.001)	8.700 *** (0.007)	2.920 *** (0.001)	-0.719 *** (0.121)	13.276 *** (0.539)	3.080 *** (0.090)
固定效应	是	是	是	是	是	是
R ²	0.040	0.082	0.046	0.076	0.122	0.062
n	31339	31339	31339	31339	31339	31339

注: ***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的水平上显著。

表 3 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的稳健性回归结果

项目	改变被解释变量		缩小样本容量		
	模型 1 工具性日常生活能力	模型 2 认知能力	模型 3 身体健康	模型 4 心理健康	模型 5 自评健康
互联网使用情况	-0.084 *** (0.024)	0.682 *** (0.097)	-0.131 *** (0.027)	-1.145 *** (0.198)	0.177 *** (0.041)
常数项	-0.719 *** (0.121)	14.170 *** (0.384)	-1.192 *** (0.115)	13.274 *** (0.562)	3.110 *** (0.093)
固定效应	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是
R ²	0.076	0.307	0.094	0.122	0.062
n	31339	22707	31230	31230	31230

注:*** 表示在 1%的水平上显著。

表 4 日常娱乐活动参与情况在互联网使用情况影响我国老年人健康状况过程中的中介作用

项目	模型 1 自评健康状况	模型 2 日常娱乐活动	模型 3 自评健康状况	模型 4 心理健康状况	模型 5 日常娱乐活动	模型 6 心理健康状况	模型 7 身体健康状况	模型 8 日常娱乐活动	模型 9 身体健康状况
互联网使用情况	0.178 *** (0.030)	0.041 *** (0.015)	0.174 *** (0.030)	-1.147 *** (0.166)	0.041 *** (0.015)	-1.099 *** (0.166)	-0.084 *** (0.019)	0.041 *** (0.015)	-0.077 *** (0.019)
日常娱乐活动			0.087 *** (0.014)			-1.150 *** (0.086)			-0.148 *** (0.013)
常数项	3.080 *** (0.071)	0.195 *** (0.027)	3.063 *** (0.071)	13.276 *** (0.463)	0.195 *** (0.027)	13.500 *** (0.462)	-0.719 *** (0.090)	0.195 *** (0.027)	-0.690 *** (0.090)
固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是
R ²	0.062	0.076	0.063	0.122	0.076	0.126	0.076	0.076	0.078
n	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339

注:*** 表示在 1%的水平上显著。

表 5 身体锻炼活动参与情况在互联网使用情况影响我国老年人健康状况过程中的中介作用

项目	模型 1 自评健康状况	模型 2 身体锻炼活动	模型 3 自评健康状况	模型 4 心理健康状况	模型 5 身体锻炼活动	模型 6 心理健康状况	模型 7 身体健康状况	模型 8 身体锻炼活动	模型 9 身体健康状况
互联网使用情况	0.178 *** (0.030)	0.100 *** (0.014)	0.159 *** (0.030)	-1.147 *** (0.166)	0.100 *** (0.014)	-1.012 *** (0.166)	-0.084 *** (0.019)	0.100 *** (0.014)	-0.069 *** (0.019)
身体锻炼活动			0.193 *** (0.021)			-1.357 *** (0.125)			-0.143 *** (0.017)
常数项	3.080 *** (0.071)	0.058 *** (0.018)	3.069 *** (0.071)	13.276 *** (0.463)	0.058 *** (0.018)	13.355 *** (0.462)	-0.719 *** (0.090)	0.058 *** (0.018)	-0.710 *** (0.090)
固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是
R ²	0.062	0.089	0.064	0.122	0.089	0.125	0.076	0.089	0.077
n	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339

注:*** 表示在 1%的水平上显著。

结果表明,互联网使用通过提升老年人参与志愿服务的频率,显著改善了其自评健康、心理健康和身体健康状况。引入志愿服务变量后,其对各类健康指标均表现出显著影响,且互联网使用的系数依然显著($P<0.01$),说明志愿服务在其中发挥了部分中介作用。

2.5 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的异质性分析

2.5.1 地区异质性。将样本划分为东部、中部和西部

地区进行回归,表 7 展示了互联网使用情况对不同地区老年人健康状况的影响。结果显示,在身体健康方面,互联网使用对东部(系数为-0.068, $P<0.1$)和中部地区(系数为-0.136, $P<0.01$)的老年人健康状况具有显著影响,而西部地区该影响不显著。在心理健康方面,互联网使用情况在中部地区影响最为显著(系数为-1.413, $P<0.01$)。而在自评健康方面,互联网使用对东部和中部地区老年人健康状况

的改善具有统计显著性,回归系数分别为 0.135 ($P<0.05$) 和 0.236 ($P<0.01$),但在西部地区影响不显著 ($P>0.1$)。上述结果表明,互联网使用情况对老年人健康状况的影响存在明显的地区异质性。

2.5.2 年龄异质性。按照老年人参与调查时的年龄进行分组,将样本分为 60–69 岁的低龄老年人和超过 69 岁的中高龄老年人分别进行回归,回归结果见表 8。结果显示,对于低龄老年人而言,互联网使用

情况对老年人身体健康状况、心理健康状况、自评健康状况的影响效应为 -0.093 ($P<0.01$)、 -1.083 ($P<0.01$)、 0.182 ($P<0.01$)。对于中高龄老年人而言,互联网使用情况对老年人身体健康状况、心理健康状况、自评健康状况的影响效应为 -0.134 ($P<0.05$)、 -0.988 ($P<0.05$)、 0.125 ($P>0.1$)。上述结果表明,互联网使用情况对老年人健康状况影响的方向、程度及显著性上均存在明显年龄异质性。

表 6 志愿服务参与情况在互联网使用情况影响我国老年人健康状况过程中的中介作用

项目	模型 1 自评健康状况	模型 2 志愿服务参与	模型 3 自评健康状况	模型 4 心理健康状况	模型 5 志愿服务参与	模型 6 心理健康状况	模型 7 身体健康状况	模型 8 志愿服务参与	模型 9 身体健康状况
互联网使用情况	0.178 *** (0.030)	0.044 *** (0.008)	0.171 *** (0.030)	-1.147 *** (0.166)	0.044 *** (0.008)	-1.105 *** (0.167)	-0.084 *** (0.019)	0.044 *** (0.008)	-0.079 *** (0.019)
志愿服务参与			0.162 *** (0.050)			-0.958 *** (0.285)			-0.096 ** (0.041)
常数项	3.080 *** (0.071)	0.000 (0.007)	3.080 *** (0.071)	13.276 *** (0.463)	0.000 (0.007)	13.276 *** (0.463)	-0.719 *** (0.090)	0.000 (0.007)	-0.719 *** (0.090)
固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是
R^2	0.062	0.023	0.062	0.122	0.023	0.122	0.076	0.023	0.076
n	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339	31339

注:***、** 分别表示在 1%、5%的水平上显著。

表 7 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的地区异质性分析

项目	模型 1 东部 身体健康状况	模型 2 中部 身体健康状况	模型 3 西部 身体健康状况	模型 4 东部 心理健康状况	模型 5 中部 心理健康状况	模型 6 西部 心理健康状况	模型 7 东部 自评健康状况	模型 8 中部 自评健康状况	模型 9 西部 自评健康状况
互联网使用情况	-0.068 * (0.040)	-0.136 *** (0.045)	-0.023 (0.045)	-0.988 *** (0.274)	-1.413 *** (0.395)	-1.298 * (0.660)	0.135 ** (0.057)	0.236 *** (0.085)	0.077 (0.097)
常数项	-0.767 *** (0.179)	-0.656 *** (0.221)	-0.856 *** (0.274)	12.034 *** (0.698)	12.568 *** (0.898)	15.483 *** (1.268)	3.161 *** (0.157)	3.144 *** (0.155)	2.886 *** (0.168)
固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是
R^2	0.061	0.068	0.089	0.094	0.103	0.118	0.055	0.044	0.055
n	10126	11449	7944	10126	11449	7944	10126	11449	7944

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%的水平上显著。

表 8 互联网使用情况对我国老年人健康状况影响的年龄异质性分析

项目	模型 1 低龄老年人 身体健康状况	模型 2 中高龄老年人 身体健康状况	模型 3 低龄老年人 心理健康状况	模型 4 中高龄老年人 心理健康状况	模型 5 低龄老年人 自评健康状况	模型 6 中高龄老年人 自评健康状况
互联网使用情况	-0.093 *** (0.025)	-0.134 ** (0.060)	-1.083 *** (0.222)	-0.988 ** (0.385)	0.182 *** (0.043)	0.125 (0.079)
常数项	-0.437 ** (0.171)	-1.099 *** (0.263)	12.905 *** (1.221)	14.036 *** (1.203)	3.351 *** (0.146)	2.519 *** (0.185)
固定效应	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是
R^2	0.053	0.081	0.133	0.110	0.066	0.061
n	19910	11429	19910	11429	19910	11429

注:***、** 分别表示在 1%、5%的水平上显著。

3 讨论

3.1 互联网使用情况能够影响我国老年人健康状况

结果显示,互联网使用情况客观上能影响老年人的身体健康与心理健康状况,主观上互联网使用能够显著改善老年人对自身健康状况的评价。在身体健康方面,互联网拓宽了老年人获取健康知识和医疗资源的渠道。老年人能够通过网络平台学习科学饮食与康复锻炼方法,借助健身类 APP 制定个性化运动计划,在数字工具的引导下坚持规律锻炼,从而有效提升身体功能^[27-28]。此外,“互联网+医疗健康”平台的发展,使老年人能够更便捷地接受远程问诊和健康监测,缓解因就医距离远、无人陪伴带来的现实困难,进一步改善了老年人的身体健康状况。在心理健康方面,互联网为老年人提供了丰富的情感交流与心理调适途径。通过网络社交平台,老年人能够维系亲属关系、拓展朋友圈,减少孤独感和社会隔离感。同时,互联网为他们提供了表达自我和获得社会认同的机会,例如通过线上分享生活点滴、参与兴趣社区等。这些因素共同作用,有助于缓解抑郁情绪,提升心理健康水平^[29]。在自评健康方面,互联网使用显著提升了老年人对自身健康状况的积极评价。一方面,互联网提供的健康知识与医疗服务,使老年人更有信心掌控自身健康;另一方面,通过网络渠道获取正向的健康信息和积极案例,有助于强化他们对身体与心理状态的正面认知。自评健康不仅反映了个体的主观感知,还与实际健康状况高度相关,因此健康状况的改善在很大程度上体现了互联网对老年人整体健康的正向影响^[30-31]。

3.2 互联网使用情况可以通过社会参与机制影响我国老年人健康状况

结果显示,互联网使用情况能够通过文体娱乐活动、志愿服务活动等社会参与路径,对老年人的身体健康状况、心理健康状况和自评健康状况产生影响。老年人可以通过互联网开展社交、便捷获取信息、利用网络娱乐服务愉悦身心等^[5],他们更愿意使用互联网来增加社会参与,并从中体会到乐趣,从而有利于改善健康状况^[32]。深入分析这一结果背后的原因,一方面,从数字素养角度来看,随着国家积极推动“智慧助老”行动,老年人的数字技能有所提升,使其更有能力通过互联网链接丰富的社会参与资源^[33]。根据社会参与理论,当老年人借助互联网突破时间和空间限制,参与多样化的文体娱乐与志愿服务时,能够有效实现自我价值,满足社交与归属

需求,从而促进身心健康^[34]。另一方面,互联网平台的信息传播优势,让老年人能更便捷获取健康知识和运动指导,间接改善健康状况^[35]。在《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》的指引下,我国加速推进适老化平台建设,从技术层面保证老年用户通过互联网获取健康信息的简便性,降低老年人通过线上设备获取信息的门槛,充分发挥互联网设备作为信息传播渠道的作用,使老年人能够从线上渠道获得积极健康的生活方式信息,提高其数字健康素养,改善其健康状况。

3.3 互联网使用情况对我国不同地区和年龄的老年人健康状况的影响存在显著差异

从异质性分析结果可知,互联网使用情况对我国老年人健康状况的影响存在明显的地区和年龄差异。地区层面,互联网使用情况对老年人健康状况的影响效应呈现出中部、东部、西部依次递减的特征;年龄层面,低龄老年人从互联网使用中获得的健康增益明显高于中高年龄群体。深入探究其原因,一方面,各地区在数字基础设施和数字服务供给能力上存在显著差距。近年来,中部地区加速推进“新型基础设施建设”,城乡网络覆盖水平明显提升,适老化应用推广力度增强,为老年人通过互联网获取健康信息、参与线上医疗和社交互动创造了较好的条件^[36]。这种相对“普惠性”的数字供给,有效降低了老年人群体内部的使用门槛,使得互联网使用带来的健康效应得以在更广泛群体中显现。已有研究也指出,中部地区在政策支持与数字基础设施加速普及的推动下,互联网使用情况对老年人健康状况的积极影响能够得到更为充分的释放^[37]。相比之下,东部地区虽已处于数字发展前沿,但互联网应用更多集中于智慧医疗、大数据健康管理等高阶领域,对具备较高教育水平和经济条件的老年群体更有利,导致群体内部差异进一步放大。有研究表明,正是由于东部地区虽然数字基础设施高度完善,但老年人群体内部因人力资本与经济条件差异而呈现出明显的“数字鸿沟”,在一定程度上扩大了健康差距^[38]。西部地区则因经济基础薄弱、地理环境复杂,网络普及率和适老化服务水平相对不足,老年人触网门槛较高,整体健康效应受限。另一方面,不同年龄段老年人的数字素养与健康需求存在差异。低龄老年人身体机能较好,学习能力相对较强,更易掌握互联网使用技能,且更积极通过网络参与文体活动、获取健康知识;中高年龄老年人则因认知衰退、操作困难等问题,难以充分利用互联网资源。因此,针

对数字基建薄弱的西部地区,加大网络资费补贴与适老化数字服务投入,推进精准降费工作,降低老年人网络使用成本^[39]。对于中部地区,应在现有成果基础上进一步推动数字公共服务的普及,提升城乡均衡水平,持续扩大互联网使用情况对老年人健康状况的积极影响。对于东部地区,则需要更加重视数字发展过程中“内部差距”的问题。应加强普惠性数字服务供给,优化适老化应用设计,避免过度复杂化,确保低教育、低收入以及高龄老年人同样能够从中受益,从而缓解“数字鸿沟”带来的健康差距。此外,建立分层数字教育体系,为低龄老年人开设高阶互联网应用课程,助力其深度参与社会活动,针对中高龄老年人开展“一对一”基础操作培训,重点解决健康类应用的使用难题,切实缩小年龄带来的数字素养差距^[40],推动数字融入与健康平等协同发展。中共中央、国务院发布的《“健康中国 2030”规划纲要》将普及健康生活作为健康中国建设的 5 项重点内容之一,体现出国家对于老年人健康生活的重视,要在数字包容理念的指导下,让老年人更好共享信息化发展成果,推动数字融入、健康平等、城乡融合协同共进。

参考文献

- [1] 李豪豪,李卓群.患慢性病对老年人抑郁症状的影响[J]. 中国健康教育,2024,40(6):525-530.
- [2] 戚冉,盛百合,张馨予,等.我国老年人抑郁和焦虑症状与心脏病及慢性非传染性呼吸系统疾病的关联性研究[J].中国慢性病预防与控制,2023,31(12):881-886.
- [3] SZABO A, ALLEN J, STEPHENS C, et al. Longitudinal analysis of the relationship between purposes of Internet use and well-being among older adults [J]. The Gerontologist, 2019, 59 (1): 58-68.
- [4] 翟亚,尹文强,李万鹏,等.中国老年人互联网使用现状及其对抑郁症状影响[J].中国公共卫生,2023,39(3):365-369.
- [5] RENNOCH G, SCHLOMANN A, ZANK S. The relationship between Internet use for social purposes, loneliness, and depressive symptoms among the oldest old [J]. Res Aging, 2023, 45(9-10): 630-642.
- [6] LI P, ZHANG C, GAO S, et al. Association between daily Internet use and incidence of chronic diseases among older adults:prospective cohort study [J]. J Med Internet Res, 2023, 25(1):e46298.
- [7] 吴怡萱,唐丹,王大华.老年人孤独感与互联网使用和躯体健康的关系[J].中国心理卫生杂志,2024,38(5):426-432.
- [8] 汤华萌,袁典琪,王明星,等.互联网使用情况对我国城乡老年人健康生活方式的影响[J].医学与社会,2024,37(9):33-38.
- [9] 王胜今,董鸿女.互联网使用对老年人健康的影响研究——基于性别差异和代际支持的视角[J].人口学刊,2024,46(2):77-92.
- [10] 王文超,冯晓晨,鲜国炜,等.互联网使用对空巢老人抑郁的影响——日常生活活动能力和社会参与的链式中介作用[J].现代预防医学,2025,52(1):86-91.
- [11] 郭静,徐艺珊,陈诗璐,等.互联网使用对老年人孤独感的影响研究——年龄的调节作用[J].中国卫生政策研究,2021,14(8):29-36.
- [12] 北京大学中国社会科学调查中心.中国健康与养老追踪调查 (CHARLS) [EB/OL]. [2025-06-19]. <https://charls.pku.edu.cn>.
- [13] LIU N, CADILHAC D A, KILKENNY M F, et al. Changes in the prevalence of chronic disability in China [J]. Public Health, 2020, 185(1): 102-109.
- [14] 张良文,方亚.2020-2050 年我国城乡老年人失能规模及其照护成本的预测研究[J].中国卫生统计,2021,38(1):39-42.
- [15] 刘影,姜俊丞,景汇泉.我国东、中、西部地区中老年人失能及其影响因素的区域差异研究[J].中国全科医学,2024,27(7):877-885.
- [16] 黎羽扬,郑晓,张持晨.福利还是负担:隔代照料强度对老年人多维健康的影响[J].中国卫生事业管理,2025,42(3):334-338.
- [17] 曾子豪,胡义秋,彭丽仪,等.挫败感对青少年心理健康的影响:压力知觉与人际关系的作用[J].心理发展与教育,2024,40(6):865-876.
- [18] PANY W, PILHARTOVA J, BOBAK M, et al. Reliability and predictive validity of two scales of self-rated health in China: results from China health and retirement longitudinal study (CHARLS) [J]. BMC Public Health, 2022, 22(1): 1863.
- [19] 张瑞芹,孙俊俊,聂丽,等.互联网使用对中国老年慢性病患者抑郁症状的影响——社会隔离的中介效应[J].中国慢性病预防与控制,2025,33(1):15-21.
- [20] 盛亦男,刘远卓.社会参与对老年人健康的影响[J].中国人口科学,2022(6):97-110.
- [21] 文静,彭华茂,王大华.社区老年人的日常活动偏好研究[J].中国老年学杂志,2010,30(13):1865-1867.
- [22] 谢宇菲,封进.长期护理保险缩小了失能老人健康差距吗? [J].保险研究,2022(10):19-33.
- [23] 吴旭红,谢舒婕.互联网使用、老年人健康与适老化应对——基于中国健康与养老追踪调查 (CHARLS) 的实证研究[J].电子政务,2024(5):101-118.
- [24] 赵传欣,魏巍,宫春博.社交活跃度视角下我国老年人社会参与情况对其健康状况的影响[J].医学与社会,2025,38(7):86-92.

(下转第 94 页)

- [30] XU Y, HUA Q, CHEN W, et al. Human adaptation to high altitude[J]. Natl Sci Rev, 2025, 12(7):nwaf203.
- [31] 国家体育总局. 全民健身指南[EB/OL]. [2025-10-11]. <https://www.sport.gov.cn/n315/n20067006/c20324479/content.html>.
- [32] PINCKARD K, BASKIN K K, STANFORD K I. Effects of exercise to improve cardiovascular health[J]. Front Cardiovasc Med, 2019, 6(1):69.
- [33] XU W, CENG M, YAO J, et al. Influence of the exercise- psychology adjustment mode on the mental health of medical workers[J]. Iran J Public Health, 2017, 46(6):782-791.
- [34] 李继军. 体育锻炼缓释医护人员心理压力的相关几个问题探讨[J]. 当代体育科技, 2017, 7(33):201-203.
- [35] 周鑫, 李卫平, 王书平, 等. 西藏各级医疗机构医生人力资源现状调查分析[J]. 中国医院管理, 2016, 36(9):51-53.
- [36] 旦增米玛, 扎西措姆. 西藏拉萨地区 15 岁以上居民生活相关行为现况调查[J]. 西藏医药, 2022, 43(5):81-83.
- [37] 白玛康卓, 春花, 央拉, 等. 西藏拉萨地区世居成年藏族居民饮酒行为调查[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(5):609-612.
- [38] BURGOS-SANCHEZ C, JONES N N, AVILLION M, et al. Impact of alcohol consumption on snoring and sleep apnea: a systematic review and meta-analysis[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2020, 163(6):1078-1086.
- [39] DING C, NG FAT L, BRITTON A, et al. Binge-pattern alcohol consumption and genetic risk as determinants of alcohol-related liver disease[J]. Nat Commun, 2023, 14(1):8041.
- [40] HU Y, YANG Y, GAO Y, et al. The impact of chronic diseases on the health-related quality of life of middle-aged and older adults: the role of physical activity and degree of digitization[J]. BMC Public Health, 2024, 24(1):2335.
- [41] 陈松森, 郑元明, 张秀芳, 等. 西藏高原红细胞增多症发病率及其血红蛋白特异性研究[J]. 中国医学科学院学报, 1992(4):237-243.
- [42] 刘弯弯. 基于西藏地区饮食习惯的肝硬化健康宣教[J]. 西藏医药, 2019, 40(5):158-159.
- [43] 罗玲霞, 李婧, 吴芳, 等. 基于 MBI-GS 量表调查急诊医务人员职业倦怠现状及影响因素[J]. 中南大学学报(医学版), 2024, 49(6):981-988.

(收稿日期 2025-11-28; 编辑 韩丹妮)

(上接第 62 页)

- [25] WOOLDRIDGE J M. Econometric analysis of cross section and panel data[M]. Cambridge: MIT Press, 2010.
- [26] 冯晓晨, 苏森贤, 王永强, 等. 我国空巢老年人数字素养、社交活跃度和心理健康的关系研究[J]. 中国卫生事业管理, 2025, 42(7):806-810.
- [27] LIAO S, ZHOU Y, LIU Y, et al. Variety, frequency, and type of Internet use and its association with risk of depression in middle- and older aged Chinese: a cross-sectional study [J]. J Affect Disord, 2020, 273(1):280-290.
- [28] 张双玲, 满晓霞, 张翔, 等. “互联网+居家健身”——新冠肺炎疫情下的全民健身新模式[J]. 健康研究, 2020, 40(6):611-614.
- [29] 尚雪, 侯丁淳, 孙玉梅. 我国中老年人志愿服务参与情况与认知功能障碍风险关联的队列研究[J]. 护理研究, 2025, 39(11):1801-1806.
- [30] 吴晶, 郎颖. 医疗服务可及性对老年人健康的影响[J]. 中国卫生统计, 2021, 38(6):912-915.
- [31] 胡重蝶, 刘艳丽, 刘小菲, 等. 积极老龄化背景下老年人电子健康素养研究进展[J]. 中国健康教育, 2024, 40(5):446-450.
- [32] 杨梦瑶, 李知一, 李黎明. 互联网使用与老年人的心理健康——基于两级数字不平等的视角[J]. 人口与发展, 2022, 28(6):132-147.
- [33] 阙霜, 曾雁冰, 方亚. 基于 logistic 回归与决策树模型的社会资本对老年人自评健康的影响研究[J]. 中国卫生统计, 2022, 39(2):186-191.
- [34] 马蕊, 许军, 廖生武, 等. 社会参与和城镇老年人健康适应能力状况的关联效应分析[J]. 中国卫生事业管理, 2024, 41(10):1174-1179.
- [35] 秦涵书, 肖明朝, 胡磊. 互联网医疗服务适老化研究[J]. 中国医院, 2022, 26(8):47-49.
- [36] 闵淑慧, 郭芮绮, 成晓芬, 等. 流动老人多维健康的潜在类别及其影响因素分析[J]. 中国卫生事业管理, 2024, 41(2):218-224.
- [37] XU X J, ZHANG Y Y, WANG Y D, et al. Impact of regional digital transformation on public health: an empirical analysis based on 31 provinces in China[J]. BMC Public Health, 2025, 25(1):2485.
- [38] 马嘉蕾, 宋佳莹, 高传胜. 互联网使用对老年人健康不平等的影响: “数字鸿沟”还是“数字红利”? ——基于人力资本和社会资本的调节作用[J]. 兰州学刊, 2023(11):130-146.
- [39] 万和平, 王颖, 方律颖, 等. “机构-社区-居家”养老格局下医养结合模式探索[J]. 中国卫生资源, 2018, 21(1):61-66.
- [40] 靳永爱, 胡文波, 冯阳. 数字时代的互联网使用与中老年人生活——中国老年群体数字鸿沟与数字融入调查主要数据结果分析[J]. 人口研究, 2024, 48(1):40-55.

(收稿日期 2025-11-08; 编辑 韩丹妮)